



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGORGANISASIAN
INSTALASI RAWAT INAP
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 998.2/I-PDM/DIR/X/2025

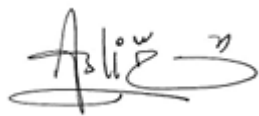
Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Rawat Inap



dr. Yoga Waranugraha, SpJP(K)

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 998.2/I-PDM/DIR/X/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT INAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT INAP

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Pertama terlampir dalam peraturan ini

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 129.2/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan KaruniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap RS Prima Husada Malang Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi gambaran umum Rumah Sakit Prima Husada hingga struktur organisasi Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan panduan ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku panduan ini.

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT INAP

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Pelaksana

1. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
2. Afni Nur Ainy, S. Kep. Ns
3. Khusnul Khotimah, S.Kep, Ns
4. Wiwit Indah Yanti, S. Kep. Ns
5. Very Susanto, S. Kep. Ns
6. Siti Zaimah, AMd. Keb
7. Dhora Meryda, S.Kep, Ns

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PENGESAHAN ii

PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA iii

KATA PENGANTAR vii

TIM PENYUSUN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II STANDAR KETENAGAAN 3

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 3

2.2. Distribusi Ketenagaan 3

2.3. Pengaturan Jaga 4

BAB III STANDAR FASILITAS 5

3.1. Denah Ruang 5

3.2. Standar Fasilitas 5

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN 10

4.1. Pelayanan Rawat Inap Yang Bisa Dilakukan di RSPH 10

4.2. Pelayanan Rawat Inap Yang Tidak Bisa Dilakukan di RSPH 10

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN 11

5.1. Skrining Pasien Masuk Rawat Inap 11

5.2. Penundaan Dan Kelambatan Pelayanan 12

5.3. Asuhan Pasien Rawat Inap 12

5.4. Kesenambungan Pelayanan Pasien 12

5.5. DPJP 14

5.6. Transfer Pasien 14

5.7. Pemulangan Dari Rumah Sakit 15

5.8. Penolakan Rencana Asuhan Medis 16

5.9. Rujukan Pasien 17

5.10. Transport Pasien 18

BAB VI LOGISTIK 19

BAB VII KESELAMATAN PASIEN 22

7.1. Pengertian 22

7.2. Tujuan 22

7.3. Standar Keselamatan Pasien 22

7.4. Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan 22

7.5. Tata Laksana 22

BAB VIII KESELAMATAN KERJA 25

8.1. Latar Belakang 25

8.2. Pengertian 25

8.3. Tujuan 25

8.4. Tata Laksana Keselamatan Kerja 25

8.5. Prinsip Keselamatan Kerja 26

BAB IX PENINGKATAN MUTU 27

9.1. Prinsip 27

9.2. Definisi Indikator 27

9.3. Kriteria 28

9.4. Standar 28

BAB X PENUTUP 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Organisasi 5

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Unit Kamar Instalasi Rawat Inap..... 8

Gambar 7.1 Tata Hubungan Kerja..... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1 Pola Ketenagaan dan Kualifikasi 17

Tabel 9.1 Kegiatan Orientasi 25

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 998.2/I-PDM/DIR/X/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI RAWAT INAP

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT INAP

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Menurut American Hospital Association (1974) Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rumah Sakit Prima Husada adalah rumah sakit swasta yang berada di Kota Malang. Dalam perkembangan industri perumahan sakitan yang kompetitif ini, Rumah Sakit Prima Husada juga harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Prima Husada antara lain Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Kamar Operasi, dan lain-lain.

Pelayanan rawat inap yang aman dan nyaman merupakan factor penting yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Sesuai visi dan misi RS Prima Husada yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat dan akurat. Pelayanan rawat inap harus bisa diberikan seoptimal mungkin dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien tanpa membedakan status sosial, golongan, suku dan agama.

Pelayanan rawat inap yang meliputi perawatan persalinan, perawatan anak, dewasa dan bedah sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka di Instalasi Rawat Inap perlu dibuat standar pelayanan yang merupakan pedoman bagi semua pihak dalam tata cara pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada pasien pada umumnya. Dalam melakukan pelayanan di Rawat Inap harus berdasarkan standar pelayanan Rawat Inap RS Prima Husada.

Upaya untuk mendukung peningkatan mutu dan terlaksananya program kerja di bagian masing-masing diperlukan SDM yang berkualitas. Seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia yang baik diharapkan sebuah institusi dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;

-
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
 12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Prima Husada Malang.

2. Tujuan

- a. Memudahkan bagi pemberi jasa pelayanan rawat inap secara umum dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan professional
- b. Setiap pemberi jasa pelayanan khususnya keperawatan dapat bekerja berdasarkan Visi, Misi, Falsafah, dan Tujuan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Prima Husada Malang

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1. Deskripsi RS Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email sekretariat@malang.rs-primahusada.com, website www.rs-primahusada.id.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2. Sejarah Institusi RS Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada. Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan sebagai berikut :

Tahun 1990 – 2005	: Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	: Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	: Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	: Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	: Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	: Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	: Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	: Akreditasi Paripurna
Desember 2016	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	: Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	: Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	: Menjadi tempat dokter internsip
Maret 2020	: Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Covi19 di Jawa Timur (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

3.1. Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2. Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan yang bermutu dengan berorientasi pada keselamatan dilandasi dengan hati yang penuh kasih pada sesama.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3. Falsafah

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4. Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5. Tujuan

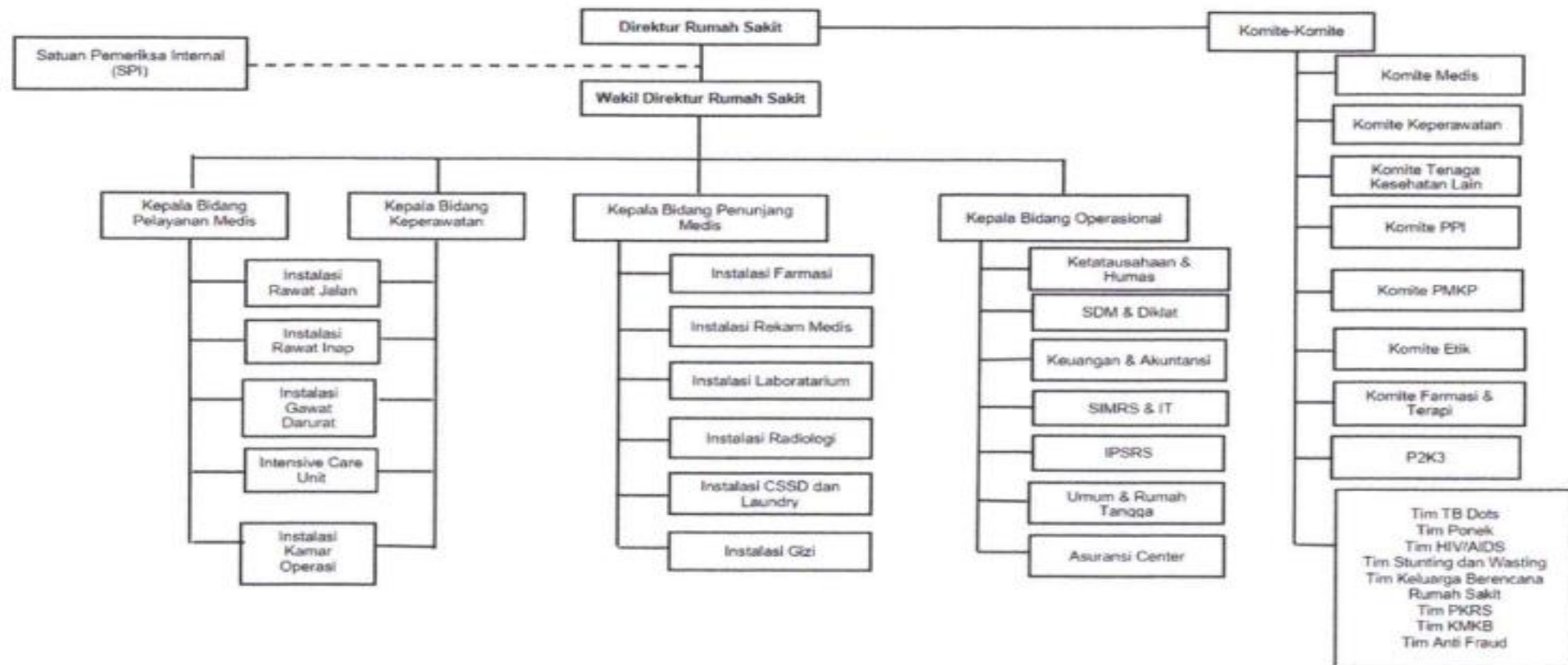
Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

3.6. Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA

4.1 Bagan Organisasi



4.2. Keterangan / Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
- 3) Kepala Bidang Keperawatan membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit lebih khususnya pada bagian keperawatan
- 4) Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tnagga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

c. Kepala Sub Bidang

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.

d. Kepala Sub Bagian

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :

- 1) Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.
- 3) Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasaran Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen KOntrak dan Pengaduan Pelayanan

e. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
- 2) Kepala Instalasi Rawat Inap
- 3) Kepala *Intensive Care Unit*
- 4) Kepala Instalasi Gawat Darurat
- 5) Kepala Instalasi Kamar Operasi
- 6) Kepala Instalasi Farmasi
- 7) Kepala Instalasi Rekam Medis
- 8) Kepala Unit Laboratorium
- 9) Kepala Unit Radiologi
- 10) Kepala Unit Gizi
- 11) Kepala Unit Laundry
- 12) Kepala Unit Kamar Jenazah
- 13) Kepala Unit Fisioterapi
- 14) Kepala Bagian SDM
- 15) Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi

16) Kepala Bagian Umum

2. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite PPI
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Etik
- f. Komite Farmasi & Terapi
- g. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- i. Tim Rekam Medis
- j. Tim TB DOTS
- k. Tim PONEK
- l. Tim Geriatri
- m. Tim HIV
- n. Tim PKRS
- o. Tim Casemix

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI RAWAT INAP

5.1. Struktur Organisasi Instalasi Rawat Inap



Gambar 5.1. Struktur Organisasi Instalasi Rawat Inap

BAB VI

URAIAN JABATAN

6.1. Uraian Jabatan

1. Direktur RS Prima Husada
 - a. Mengetahui dan mematuhi semua perundang-undangan terkait dengan rumah sakit
 - b. Menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi rumah sakit
 - c. Menetapkan regulasi rumah sakit
 - d. Memberikan arahan kebijakan rumah sakit
 - e. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien selama dilayani di rumah sakit
 - g. Membuat dan menjalankan program kerja yang disusun dalam rencana strategis tahunan, rapat koordinasi, maupun forum lain
 - h. Membuat laporan penyelenggaraan operasional rumah sakit secara berkala
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Merencanakan kegiatan pelayanan medik meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, pelayanan kesehatan akibat bencana dan wabah serta pelayanan.
 - b. Merencanakan kebutuhan ketenagaan, pengembangan mutu layanan, pengembangan kualitas dan kompetensi petugas medik, peralatan dan sarana lainnya untuk pelayanan medis.
 - c. Menyusun, kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan medik.
 - d. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas
 - e. Mengatur pelaksanaan pelayanan medik paripurna bagi pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif serta berkoordinasi dengan kabinid pelayanan penunjang.
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan medik
 - h. Mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
 - i. Menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggung jawaban pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik.
 - j. Melakukan koordinasi wakil direktur dan direktur.
 - k. Melakukan koordinasi dengan komite medik.
3. Kepala Bidang Keperawatan
 - a. Merencanakan jumlah dan kategori tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.
 - b. Merencanakan jumlah dan jenis peralatan keperawatan yang dibutuhkan di unit perawatan sesuai kebutuhan.
 - c. Merencanakan dan menentukan jenis kegiatan/ asuhan keperawatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan pasien.
 - d. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan.
 - e. Melaksanakan program orientasi kepada staf perawat baru yang akan bekerja.
 - f. Memberi pengarahan dan motivasi kepada staf keperawatan untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai ketentuan/standar
 - g. Mengadakan pertemuan berkala dengan pelaksana perawatan.
 - h. Mengenal jenis dan kegunaan barang/peralatan serta mengusahakan pengadaannya sesuai kebutuhan pasien agar tercapai pelayanan optimal.
 - i. Menyusun permintaan rutin meliputi kebutuhan alat, obat dan bahan lain yang diperlukan.
 - j. Mengatur dan mengkoordinasi pemeliharaan peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai.

-
- k. Memelihara dan mengembangkan system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kegiatan lain yang dilakukan secara tetap dan benar.
 - l. Mengadakan kerjasama yang baik dengan kepala unit lain, kepala bidang dan kepala bagian lain.
 - m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara petugas, pasien dan keluarganya.
 - n. Membuat laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan serta kegiatan lain
 - o. Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan.
 - p. Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan, pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan.
4. Kepala Instalasi Rawat Inap
- a. Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Keperawatan dalam bidang teknis fungsional pada instalasi rawat inap
 - b. Melaksanakan pelayanan selama 24 jam dalam rangka penanganan pasien rawat inap
 - c. Melakukan pelayanan diagnostic, tindakan dan pengobatan rawat inap
 - d. Menyusun program, mengatur dan mengawasi kebutuhan pelayanan tindakan rawat inap
 - e. Membuat prosedur tetap pelayanan pada setiap jenis tindakan medis
 - f. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berkala
 - g. Berkolaborasi dengan profesi medis untuk tindakan-tindakan medis
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur rumah sakit
5. Kepala Ruang Rawat Inap
- a. Menyusun rencana kerja
 - b. Berperan serta menyusun visi, misi, falsafah, tujuan keperawatan dan tujuan khusus ruang keperawatan'menyusun rencana kebutuhan staf perawat dari segi jumlah maupun kualifikasi untuk di ruang rawat
 - c. Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan di ruang perawatan melalui kerjasama dengan staf lain
 - d. Menyusun jadwal dan daftar dinas staf perawat
 - e. Melaksanakan orientasi kepada staf baru
 - f. Membimbing staf perawat untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar
 - g. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan keperawatan/ kebidanan
 - h. Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya
 - i. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan
 - j. Melakukan penilaian kinerja perawat yang berada dibawah tanggung jawabnya
 - k. Mengawasi dan menilai pendayagunaan staf perawat, peralatan dan obat-obatan
 - l. Mengawasi dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai standar yang berlaku secara mandiri.
6. Perawat Kepala Jaga/ Ka Shift
- a. Membuat tujuan dan rencana keperawatan'melaksanakan rencana yang telah dibuat sekama praktek bila diperlukan
 - b. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin ilmu lain maupun keperawatan
 - c. Mengevaluasi keberhasilan asuhan keperawatan
 - d. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin lain
 - e. Mengevaluasi keberhasilan yang dicapai
 - f. Menyiapkan penyuluhan untuk pulang
 - g. Melakukan pengelolaan rujukan antar rumah sakit
 - h. Mendampingi visite dokter spesialis
 - i. Melaksanakan ronde keperawatan bersama dengan kepala ruangan dan

-
- perawat associate
 - j. Melaporkan perkembangan pasien kepada dokter penanggung jawab (DPJP)
 - k. Menuliskan asuhan keperawatan pada catatan terintegrasi (CPPT)
 - l. Menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif
 - m. Mengecek kebenaran jumlah kemasan obat, kondisi kemasan obat seperti yang disyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, dan jenis produk yang diterima sebelum diberikan ke pasien
 - n. Melakukan penerimaan rujukan dari instalasi lain
7. Perawat Pelaksana
- a. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan instalasi rawat inap untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien untuk menerima pelayanan
 - b. Menerima pasien baru sesuai dengan prosedur dan kebijakan berlaku
 - c. Melaksanakan teknik septik dan aseptik
 - d. Memelihara peralatan keperawatan/ medis agar selalu dalam keadaan siap pakai
 - e. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarganya
 - f. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien dalam rangka memberikan askep dengan cara :
 - 1) Mengamati keadaan pasien (tanda vital, kesadaran, keadaan mental, dan keluhan utama, airway dan sirkulasi)
 - 2) Melaksanakan anamnesa secara cermat dan pemeriksaan fisik sesuai dengan wewenangnya
 - 3) Menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai dengan prioritas masalah
 - 4) Memberikan pertolongan basic life support (resusitasi kardiopulmoner)
 - g. Memberikan pelayanan dasar kepada pasien sesuai kebutuhan dengan cara :
 - 1) Memberikan rasa aman kepada pasien yang meliputi : mencegah terjadinya bahaya kecelakaan, luka, gangguan pernafasan. (bila perlu memerlukan alat bantu pernafasan), komplikasi, khususnya pada pasien yang mengalami gangguan kesadaran
 - 2) Melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program terapi
 - 3) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya, mengenai penyakitnya sesuai batas kewenangannya
 - h. Membantu merujuk pasien kepada petugas kesehatan atau institusi pelayanan lain yang lebih mampu untuk menangani/ memenuhi kebutuhan kesehatan/ menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi
 - i. Melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat secara tepat dan benar sesuai kebutuhan secara tepat dan benar sesuai kebutuhan serta merujuk yang berlaku
 - j. Selanjutnya segera melaporkan tindakan yang telah dilakukan, kepada dokter penanggung jawab (DPJP)
 - k. Melaksanakan evaluasi tindakan asuhan keperawatan dan selanjutnya melakukan tindakan yang tepat sesuai hasil pemantauan
 - l. Membantu petugas lain dalam memelihara lingkungan yang sehat
 - m. Menciptakan hubungan kerja yang baik dengan anggota tim kesehatan lain (dokter, ahli gizi, analis, farmasi, dll) di instalasi rawat inap
 - n. Melaksanakan tugas pagi, sore, malam, dan hari libur secara bergilir sesuai dengan jadwal dinas
 - o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara petugas, pasien, dan keluarganya, sehingga terciptanya ketenangan
 - p. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang perawatan, misal : melalui pertemuan ilmiah, seminar, pelatihan-pelatihan dibidang keperawatan maupun medis
 - q. Melaksanakan dan memelihara system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan secara tepat dan benar, sehingga tercipta suatu system informasi rumah sakit yang dapat dipercaya dan akurat

- r. Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti, baik secara lisan atau tertulis pada saat pergantian dinas
- s. Melaksanakan perawatan pasien dalam keadaan sakaratul maut dan merawat jenazah sesuai dengan prosedur yang berlaku
- t. Memegang teguh rahasia jabatan
- u. Melaksanakan program pendampingan pastoral/ kesehatan holistic dan program lain yang telah ditetapkan sebagai program rumah sakit
- v. Melaksanakan tindakan perawatan yang telah disusun
- w. Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah diberikan
- x. Mencatat dan melaporkan semua tindakan perawatan dan respon klien pada catatan perawatan
- y. Mengecek kebenaran jumlah kemasan obat. Kondisi kemasan obat seperti yang diisyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, dan jenis produk yang diterima sebelum diberikan ke pasien
- z. Mempersiapkan pasien operasi, benar nama pasien, diagnosis, jenis tindakan dan kelengkapan hasil penunjang
 - aa. Menyiapkan obat dan tindakan yang akan diberikan kepada pasien
 - bb. Memelihara kebersihan pasien dan lingkungan
 - cc. Melakukan pendekatan komunikasi terapeutik
 - dd. Mengurangi penderitaan pasien dengan memberi rasa aman, nyaman, dan ketenangan
 - ee. Melakukan asesmen nyeri pada pasien
 - ff. Melakukan sensus harian dan formulir

6.2. Tanggung Jawab

1. Direktur RS Prima Husada
 - a. Menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap perundang-undangan
 - b. Menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Menilai dan menyetujui rencana anggaran
 - d. Menjalankan visi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemilik
 - e. Menjamin dicapainya akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna
 - f. Menjamin tercapainya peningkatan dana, pelayanan dan kinerja keuangan rumah sakit setiap tahun
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Bertanggung jawab kegiatan pelaksanaan pelayanan medis ke wakil direktur dan direktur
 - b. Bertanggung jawab pada mutu pelayanan medis yang efektif dan efisien
 - c. Bertanggung jawab pada kebijakan yang telah disusun
 - d. Bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis
 - e. Bertanggung jawab pada monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
 - f. Bertanggung jawab pada mutu dan keselamatan pasien
 - g. Melaporkan hasil kinerja kepada Direktur Rumah Sakit
3. Kepala Bidang Keperawatan
 - a. Pemenuhan kebutuhan staf perawat di unit perawatan.
 - b. Kelengkapan asuhan keperawatan.
 - c. Bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan penunjang medis
4. Kepala Instalasi Rawat Inap
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis
 - b. Membantu dalam menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit
 - c. Menetapkan pembagian pekerjaan, Batasan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
5. Kepala Ruang Rawat Inap

- a. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan staf perawat dan bidan
 - b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan keperawatan/ kebidanan
 - c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja perawat dan bidan
 - d. Kelancaran kegiatan perawat dan bidan baru
 - e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan keperawatan/ kebidanan
6. Perawat Kepala Jaga/ Ka Shift
- a. Mengawasi pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan
 - b. Mengawasi pelaksanaan system pencatatan dan pelaporan kegiatan asuhan keperawatan serta mencatat kegiatan lain di ruang rawat inap
 - c. Mengawasi pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - d. Menjaga penerapan kode etik asuhan keperawatan dalam praktik sehari-hari
 - e. Menerapkan pertimbangan professional dalam melakukan praktik keperawatan dengan mengindahkan kode etik dan disiplin
 - f. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan bidan keperawatan secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum , dan penerapannya dalam praktik
7. Perawat Pelaksana
- a. Secara administrasi dan fungsional bertanggung jawab kepada kepala instalasi rawat inap
 - b. Secara teknis medis operasional, bertanggung jawab kepada dokter di instalasi rawat inap.
 - c. Menjaga penerapan kode etik asuhan keperawatan dalam praktik sehari-hari
 - d. Menerapkan pertimbangan professional dalam melakukan praktik keperawatan dengan mengindahkan kode etik dan disiplin
 - e. Menjelaskan ketentuan perundangan bidang keperawatan secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum, dan penerapannya dalam praktik

6.3. Wewenang

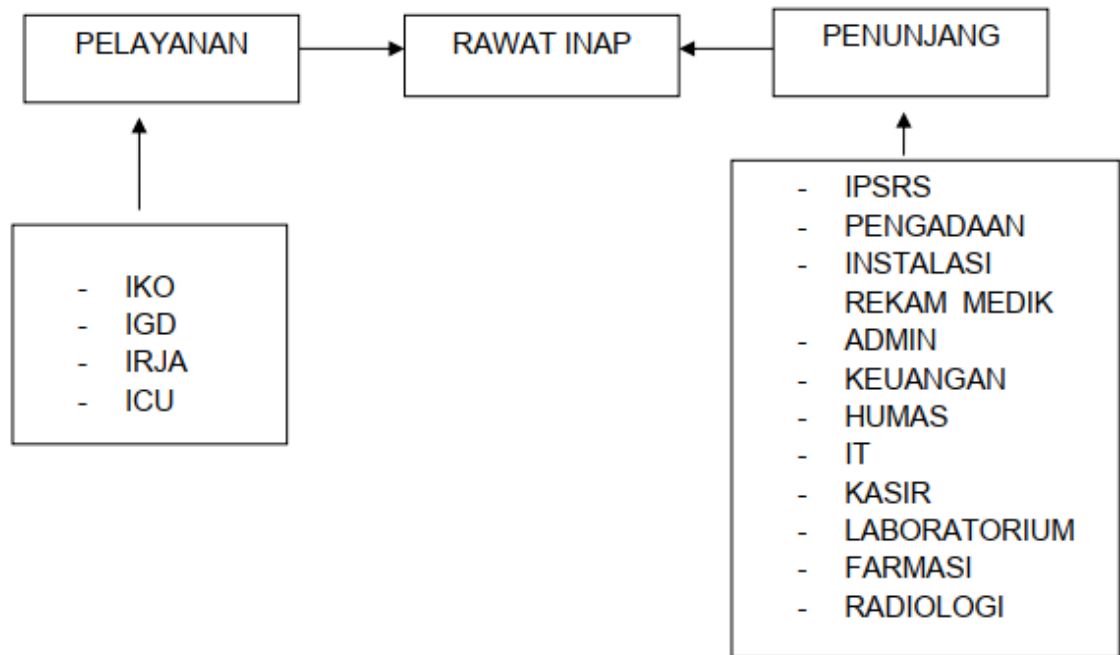
1. Direktur RS Prima Husada
 - a. Menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit internal maupun eksternal
 - b. Menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati Bersama
 - c. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit
 - d. Mengelola dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan rumah sakit sesuai dengan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan
 - e. Menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Berwenang melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan medik
 - b. Berwenang dalam Menyusun, kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan medik
 - c. Berwenang dalam mengatur pelaksanaan mutu pelayanan medis
3. Kepala Bidang Keperawatan
 - a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
 - b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan staf keperawatan.
 - c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf keperawatan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan.
 - a. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang kepala sub bidang keperawatan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan

-
4. Kepala Instalasi Rawat Inap
 - a. Menyusun rencana operasi di instalasi rawat inap
 - b. Mengorganisir sumber daya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instalasi rawat inap
 - c. Melakukan supervisi terhadap SDM di lingkungan instalasi rawat inap
 - d. Membuat usulan kebutuhan yang diperlukan di instalasi rawat inap
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidangnya
 5. Kepala Ruang Rawat Inap
 - a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan
 - b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas dan staf keperawatan dan kebidanan
 - c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf keperawatan/kebidanan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan di ruang perawatan
 - d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala ruangan
 - e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
 6. Perawat Kepala Jaga/ Ka Shift
 - a. Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan
 - b. Menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan
 - c. Menilai pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - d. Menilai tugas dan tanggung jawab perawat pelaksana
 - e. Menilai pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - f. Mengendalikan pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - g. Mengendalikan system pencatatan dan pelaporan kegiatan asuhan keperawatan serta mencatat kegiatan lain di ruang rawat inap
 7. Perawat Pelaksana
 - a. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan
 - b. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, dan kenyamanan
 - c. Melaporkan segala sesuatu mengenai keadaan klien baik lisan maupun tertulis
 - d. Melakukan observasi tanda-tanda vital setiap shift maupun pada setiap pasien yang mengalami perubahan kondisi

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

7.1. Tata Hubungan Kerja



Gambar 7.1. Tata Hubungan Kerja

7.2. Pola Hubungan Pelayanan

1. Hubungan kerja dengan Instalasi Farmasi
Permintaan obat dan alkes dengan menggunakan resep sesuai SPO
2. Hubungan kerja dengan penunjang medik
 - a. Laboratorium
Hubungan kerja dengan laboratorium untuk penegakan diagnose dengan pemeriksaan laboratorium menggunakan billing laboratorium
 - b. Radiologi
Hubungan kerja dengan radiologi untuk penegakan diagnose dengan pemeriksaan radiologi menggunakan billing pemeriksaan radiologi
 - c. Instalasi Gizi
Hubungan kerja dengan Instalasi Gizi untuk pemenuhan nutrisi dan konsultasi diet pasien dengan menggunakan lembar daftar diet
 - d. Hubungan kerja dengan IRJA dan IGD
Hubungan kerja dengan IRJA dan IGD dalam hal penerimaan pasien baru dengan menggunakan form serah terima pasien baru
 - e. Instalasi Kamar Operasi
Hubungan kerja dengan Instalasi Kamar Operasi dalam penanganan pasien yang perlu tindakan pembedahan dengan menggunakan form serah terima pasien
 - f. Intensive Care Unit
Hubungan kerja dengan Intensive Care Unit dalam penanganan pasien yang sudah lepas pelayanan di ruang Intensive Care Unit
3. Hubungan kerja dengan penunjang non medik
 - a. Bagian Pemeliharaan Sarana
Hubungan kerja dengan bagian pemeliharaan sarana dalam maintenance alat medis dan non medis dengan menggunakan lembar perbaikan bengkel
 - b. Bagian Binatu
Hubungan kerja dengan laundry untuk menyediakan linen dengan menggunakan buku pencucian
 - c. Bagian Administrasi
Hubungan kerja dengan bagian administrasi untuk perhitungan pembiayaan pasien dengan menggunakan lembar status pasien
 - d. Bagian Rekam Medis
Hubungan kerja dengan Rekam Medis dalam pendaftaran pasien baru dan penyimpanan berkas pasien, kelengkapan format RM
 - e. Bagian Umum

Hubungan kerja dengan tim umum terkait dengan kebersihan ruangan pasien rawat inap dan lingkungan kerja di rawat inap. Serta juga keamanan pada Instalasi Rawat Inap

f. Bagian IT

Hubungan kerja dengan tim IT terkait dengan jaringan internet yang menunjang pekerjaan di Instalasi Rawat Inap, berikut dengan peralatan lunak dan kerasnya juga.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

8.1. Pola Ketenagaan

Penyusunan pola ketenagaan sebagai dasar penempatan staf dalam upaya mempersiapkan tenaga perawat yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Standar tenaga di Instalasi rawat Inap Prima Husada Malang menggunakan rumus Depkes 2005. Berikut daftar perhitungan berdasarkan unit Instalasi Rawat Inap:

1. Maternitas dan Perinatologi

a. Kamar Bersalin dan Ruang Nifas

RUMUS

$$TP = \frac{\text{rata rata jumlah pasien} \times \text{jumlah jam perawatan}}{\text{Jumlah jam kerja efektif/ hari}} + \text{Loos day}$$

a. Waktu yang diperlukan untuk pertolongan persalinan mencakup kala I s/d kala IV dan nifas = 5 jam/pasien

b. Jam efektif kerja bidan per jam dalam 1 hari = 7 jam

c. Rata-rata jumlah pasien setiap hari = 13 pasien (sesuai jumlah bed)

$$d. TP = \frac{\sum px \times 5 \text{ jam/ px}}{7 \text{ jam/ hari}} + \text{Loos day } \frac{(78 \times 4)}{286}$$

$$= \frac{11 \times 5}{7} = \frac{55}{7} = 7,8 = 8 + \text{Loos day}$$

$$= 8 + \frac{(78 \times 4)}{286} = 8 + 1 = 9$$

$$\text{Total kebutuhan bidan} = 9 + 1 \text{ karu} = 10 \text{ orang}$$

b. Ruang Neonatus

RUMUS

$$TP = \frac{\text{rata rata jumlah pasien} \times \text{jumlah jam perawatan}}{\text{Jumlah jam kerja efektif/ hari}} + \text{Loos day}$$

Perawatan total care : 1-1,5 x 4 jam = 4-6 jam

Perawatan Minimal 4 jam

$$TP = \frac{\sum px \times 4 \text{ jam/ px}}{7 \text{ jam/ hari}} + \text{Loos day } \frac{(78 \times 4)}{286}$$

$$\frac{19 \times 4}{7} = \frac{76}{7} = 10,8 = 11 + \text{Loos day}$$

$$11 + \frac{(78 \times 4)}{286} = 11 + 1 = 12 \text{ orang}$$

2. IRNA 2A

- a. Tingkat ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMLAH PX/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ RUANG/ HARI
1.	Askep Minimal	0	2	0
2.	Askep Sedang	6	3,08	18,48
3.	Askep Berat	2	4,15	8,3
4.	Askep Maksimal	0	6,16	0
5.	Jumlah	8		26,78

- b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ ruang/ hari}}{7} = \frac{26,78}{7} = 3,82$$

- c. Koreksi loss day

$$52 + 12 + 14 = \frac{78 \times 3,82}{286} = 1,04$$

- d. Tugas Non keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan + loss day} \times 25}{100} = \frac{3,82 + 1,04 \times 25}{100} = 1,21$$

- e. Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$3,82 + 1,04 + 1,21 = 6,07 = 6 \text{ orang} + 1 \text{ Karu} = 7 \text{ orang}$$

3. IRNA 2C

- a. Tingkat Ketergantungan Pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMLAH PX/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ RUANG/ HARI
1	Askep Minimal	0	2	0
2	Askep Sedang	4	3,08	12,32
3	Askep Berat	4	4,15	16,6
4	Askep Maksimal	0	6,16	0
5	Jumlah	8		28,92

- b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ ruang/ hari}}{7} = \frac{28,92}{7} = 4,131$$

- c. Koreksi loss day

$$52 + 12 + 14 = \frac{78 \times 4,131}{286} = 1,126$$

- d. Tugas Non Keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan + loss day} \times 25}{100} = \frac{4,131 + 1,126 \times 25}{100} = 131,425 = 1,314$$

- e. Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$4,131 + 1,126 + 1,314 = 6,571 = 6 + 1 \text{ karu} = 7 \text{ orang}$$

4. IRNA 3A

a. Tingkat Ketergantungan Pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMLAH PX/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/RUANG/ HARI
1	Askep Minimal	0	2	0
2	Askep Sedang	4	3,08	12,32
3	Askep Berat	4	4,15	16,6
4	Askep Maksimal	0	6,16	0
5	Jumlah	8		28,92

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ ruang/ hari} = 28,92}{7} = 4,131$$

c. Koreksi loss day

$$\frac{52 + 12 + 14}{286} = 78 \times 4,131 = 1,126$$

d. Tugas Non Keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{4,131 + 1,126 \times 25}{100} = \frac{131,425}{100} = 1,314$$

e. Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$4,131 + 1,126 + 1,314 = 6,571 = 6 + 1 \text{ karu} = 7 \text{ orang}$$

5. IRNA 3C

a. Tingkat ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMLAH PX/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ RUANG/ HARI
1.	Askep Minimal	13	2	26
2.	Askep Sedang	4	3,08	12,32
3.	Askep Berat	2	4,15	12,32
4.	Askep Maksimal	0	6,16	0
5.	Jumlah	19		50,64

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ ruang/ hari} = 50,64}{7} = 7,23$$

c. Koreksi loss day

$$\frac{52 + 12 + 14}{286} = 78 \times 7,23 = 1,97$$

d. Tugas Non keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{7,23 + 1,97 \times 25}{100} = \frac{56,65}{100} = 0,5665 \approx 0,6$$

e. Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$7,23 + 1,97 + 0,6 = 9,8 = 9 \text{ orang} + 1 \text{ Karu} = 10 \text{ orang}$$

6. IRNA 4 A

a. Tingkat Ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMAH PX/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/RUANG/HARI
1	Askep Minimal	4	2	8
2	Askep Sedang	8	3.08	24,64
3	Askep Berat	4	4.15	16,6
4	Askep Maksimal	0	6.16	0
5	Jumlah	16		49,24

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari} = 49,24}{7} = 7,034$$

c. Koreksi loss day

$$\frac{52 + 12 + 14}{266} = \frac{78 \times 7,034}{266} = \frac{548,652}{266} = 2,062$$

d. Tugas non keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{7,034 + 2,062 \times 25}{100} = \frac{2,27}{100}$$

e. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan

$$7,034 + 2,062 + 2,27 = 11,3 = 11 + 1 \text{ karu} = 12 \text{ orang}$$

7. IRNA 5C

a. Tingkat Ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMAH PX/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/RUANG/HARI
1	Askep Minimal	3	2	6
2	Askep Sedang	8	3.08	24,64
3	Askep Berat	4	4.15	16,6
4	Askep Maksimal	0	6.16	0
5	Jumlah	15		47,24

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari} = 47,24}{7} = 6,74$$

c. Koreksi loss day

$$\frac{52 + 12 + 14}{266} = \frac{78 \times 6,74}{266} = \frac{525,72}{266} = 1,97$$

d. Tugas non keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{6,74 + 1,97 \times 25}{100} = \frac{2,17}{100}$$

e. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan

$$6,74 + 1,97 + 2,17 = 10,88 = 11 + 1 \text{ karu} = 12 \text{ orang}$$

8. IRNA 6A

a. Tingkat Ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMLAH PX/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/RUANG/HARI
1	Askep Minimal	2	2	4
2	Askep Sedang	8	3.08	24,64
3	Askep Berat	2	4.15	8,3
4	Askep Maksimal	0	6.16	0
5	Jumlah	12		28,64

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari} = 28,64}{7} = 4,091$$

c. Koreksi loss day

$$\frac{52 + 12 + 14}{266} = \frac{78}{266} \times 4,091 = 1,19$$

d. Tugas non keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{4,091 + 1,19 \times 25}{100} = 1,320$$

e. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan

$$4,091 + 1,19 + 1,320 = 6,601 = 7 + 1 \text{ karu} = 8 \text{ orang}$$

9. IRNA 7A

a. Tingkat Ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMLAH PX/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/RUANG/HARI
1	Askep Minimal	2	2	4
2	Askep Sedang	8	3.08	24,64
3	Askep Berat	2	4.15	8,3
4	Askep Maksimal	0	6.16	0
5	Jumlah	12		28,64

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari} = 28,64}{7} = 4,091$$

c. Koreksi loss day

$$\frac{52 + 12 + 14}{266} = \frac{78}{266} \times 4,091 = 1,19$$

d. Tugas non keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{4,091 + 1,19 \times 25}{100} = 1,320$$

e. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan

$$4,091 + 1,19 + 1,320 = 6,601 = 7 + 1 \text{ karu} = 8 \text{ orang}$$

10. IRNA 8A

a. Tingkat Ketergantungan pasien

NO	KATEGORI	RATA JUMAH PX/HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/ HARI	JUMLAH JAM PERAWATAN/RUANG/HARI
1	Askep Minimal	2	2	4
2	Askep Sedang	8	3.08	24,64
3	Askep Berat	2	4.15	8,3
4	Askep Maksimal	0	6.16	0
5	Jumlah	12		28,64

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

Jumlah jam perawatan/ruang/hari = 28,64 = 4,091

7 7

c. Koreksi loss day

52 + 12 + 14 = 78 x 4,091 = 319,098 = 1,19

266 266

d. Tugas non keperawatan 25%

Jumlah tenaga keperawatan + loss day x 25 = 4,091+ 1,19 x 25 = 1,320

100 100

e. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan

4,091+ 1,19+ 1,320 = 6,601 = 7 + 1 karu = 8 orang

8.2. Kualifikasi Staf

Table 8.1. Kualifikasi Staf

NO	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Direktur RS	S1 Kedokteran + MMRS	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	1	0
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	S1 Kedokteran + MMRS	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	1	0
3	Kepala Bidang Keperawatan	S1 Keperawatan + Ners	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	0	0

4	Kepala Instalasi Rawat Inap	S1 Kedokteran + MMRS Pendidikan dokter spesialis	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	1	0
5	Kepala Ruang Rawat Inap	S1 Keperawatan + Ners D4 Keperawatan/ Kebidanan D3 Keperawatan/ Kebidanan	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	6	0
6	Kepala Jaga/ Penanggung Jawab Shif	S1 Keperawatan + Ners D4 Keperawatan/ Kebidanan D3 Keperawatan/ Kebidanan	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	1. Maternitas dan Perinatologi = 8 2. IRNA 2A = 4 3. IRNA 2C = 4 4. IRNA 3A = 4 5. IRNA 3C = 4 6. IRNA 4A = 4 7. IRNA 5C = 4 8. IRNA 6A = 4 9. IRNA 7A = 4 10. IRNA 8A = 4	1. Maternitas dan Perinatologi= 0 2. IRNA 2A = 0 3. IRNA 2C = 0 4. IRNA 3A = 0 5. IRNA 3C = 0 6. IRNA 4A = 0 7. IRNA 5C = 0 8. IRNA 6A = 0 9. IRNA 7A = 0 10. IRNA 8A = 0
7	Perawat Pelaksana	S1 Keperawatan + Ners D4 Keperawatan/ Kebidanan D3 Keperawatan/ Kebidanan	Sertifikat yang mendukung di bidangnya PMKP PPGD/ BLS Komunikasi Efektif PPI K3RS	1. Maternitas dan Perinatologi = 18 2. IRNA 2A = 8 3. IRNA 2C = 7 4. IRNA 3A = 6 5. IRNA 3C = 12 6. IRNA 4A = 8 7. IRNA 5C = 8 8. IRNA 6A = 7 9. IRNA 7A = 7 10. IRNA 8A = 7	1. Maternitas dan Perinatologi = 4 2. IRNA 2A = 0 3. IRNA 2C = 0 4. IRNA 3A = 1 5. IRNA 3C = 1 6. IRNA 4A = 1 7. IRNA 5C = 2 8. IRNA 6A = 0 9. IRNA 7A = 0 10. IRNA 8A = 0

8.3. Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - a. Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen,

pelatihan Kegawatdaruratan Neonatus, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar ditempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)

- b. Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjagastabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
2. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama. Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
3. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - b. Seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;

Bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara.

8.4. Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf

1. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
2. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, kepala Unit, dan SDM
3. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
4. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.5 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Farmasi memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (*Internal resources*) memiliki

keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada

2. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)

Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Seleksi adalah bagian yang terpenting dalam rekrutmen tenaga kerja, dilakukan berdasarkan persyaratan jabatan. Sistem seleksi perawat baru di bidang keperawatan berdasarkan :

1. Latar Belakang Pendidikan : D3 / D4 / S1 Keperawatan atau Kebidanan
2. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja
3. IPK diatas 2,80
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Menguasai Asuhan Keperawatan / Kebidanan
6. Usia maksimal 35 tahun
7. Mudah bekerja secara mandiri atau tim
8. Hasil tes tulis dan uji kompetensi / prosedur keperawatan baik
9. Hasil tes psikology baik
10. Hasil Wawancara baik
11. Hasil Test Kesehatan baik

8.6. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Rawat Inap khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga perawat. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan farmasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat di lakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat SMA diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan DIII, dst.

2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat dan bidan di Instalasi Rawat Inap dilaksanakan melalui :

- a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD.
- b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi Rawat Inap.

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

Tabel 9.1 Kegiatan Orientasi

MINGGU/ HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
Minggu I Hari ke I - III	1. Tujuan orientasi, sejarah, visi, misi, motto RSPH, struktur organisasi RSPH 2. Peraturan kepegawaian/ KKB 3. Service excellent 4. Fasilitas, sarana, produk-produk RSPH 5. Kebijakan pasien rekanan 6. Etika dan Hukum (umum dan keperawatan) 7. Uraian tugas perawat pelaksana 8. Perencanaan pasien pulang/ discharge planning 9. Alur dan prosedur penerimaan pasien baru rawat inap dan rawat jalan 10. Alur dan tata laksana pemeriksaan penunjang medis, farmasi, gizi 11. Pencegahan infeksi nosocomial 12. Penjelasan tentang format yang ada di dalam keperawatan dan latihan pengisian format-format dalam keperawatan 13. Latihan dalam pengisian RM dan penginputan SIMRS 14. Latihan BHD dasar	8 jam	Cerama Diskusi	SDM
Hari ke IV - VI	1. Pelaksanan asuhan keperawatan dan metode penugasan 2. Sosialisasi SPO keperawatan (12 kor kompetensi dasar) 3. Etik dan Mutu Disiplin Keperawatan 4. Orientasi ruangan, penjelasan format-format penilaian	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan
Minggu ke II	1. Mengenal sistem dokumentasi keperawatan, format-format dokumen keperawatan, metode penugasan 2. Mengenal peralatan dan fasilitas seperti EKG, oksigen, suction 3. Mengenal dan melakukan memandikan pasien baru 4. Mengenal dan melakukan penerimaan pasien baru 5. Mengganti alat tenundengan dan tanpa pasien diatasnya 6. Membantu pasienmakan 7. Menolong buang air kecil dan besar ditempat tidur dan kamar mandi 8. Mengenal pengambilan bahan pemeriksaan urin dan faeces 9. Memberikan pasien posisi semi fowler 10. Memindahkan pasiendari tempat	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap

	tidur ke kursi roda/ kereta dorong 11. Mengenal dan menyiapkan obat-obatan oral dan injeksi 12. Mengenal cara-cara tindakan injeksi IM/ IV/ SC/ IC, obat oral/sup, inhalasi, NGT, Dower Catheter, perawatan luka dengan didampingi CI/ perseptor lapangan			
Minggu ke III	1. Mengenal dan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien 2. Mengenal peralatan dan fasilitas seperti nebulizer, monitor, syringe pump, infus pump, ripple bed, blood warmer 3. Mengenal dan melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan penunjang, antara lain: resep, laboratorium, diagnostik lain 4. Mengenal dokter-dokter yang merawat di ruangan 5. Mengenal dan melakukan perawatan jenazah 6. Mengajarkan latihan nafas dalam dan batuk efektif 7. Mengenal cara pemasangan infus 8. Mengenal dan melaksanakan prosedur pre/ post operasi didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 9. Mengenal cara-cara menghubungi dokter via telephone dan cara mengikuti dokter visite didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 10. Mampu menggunakan peralatan dan fasilitas dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke IV	1. Pengenalan pencegahan nosokomial (ICN di ruangan) 2. Melakukan dokumentasi keperawatan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ, meliputi: a. Pengisian pengkajian keperawatan meliputi perkembangan keperawatan b. Format penerimaan pasien baru, pasien pulang, pindah ruangan dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 3. Mengenal dan melaksanakan prosedur pre/post operasi didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 4. Mengenal cara-cara menghubungi dokter via telephone dan cara mengikuti dokter visite didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 5. Mampu menggunakan peralatan dan fasilitas dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap

Minggu ke V	1. Menenal dan melakukan konsul internal dan eksternal dokter spesialis RSPH 2. Menyiapkan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan penunjang mandiri meliputi: laboratorium, radiologi, diagnostik lain, resep, dll 3. Melakukan dokumentasi keperawatan mandiri, meliputi: a. Pengisian pengkajian keperawatan meliputi perkembangan keperawatan b. Format penerimaan pasien baru, pasien pulang, pindah ruangan 4. Melakukan penggunaan peralatan dan fasilitas EKG, Suction secara mandiri 5. Melakukan perawatan Hygiene, menerima pasien baru, pengkajian secara mandiri 6. Mengganti alat tenun dengan pasien atau tanpa pasien diatasnya, membantu pasien makan dan menolong buang air kecil dan besar secara mandiri 7. Mampu mengambil bahan untuk pemeriksaan urin dan faeces serta mengirimnya ke laboratorium	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke VI	1. Melakukan tindakan injeksi IV/ IM/ SC/ IC, obat oral/supp (anal/vaginal), inhalasi perawatan luka dengan didampingi CI/ Kepala ruang/ PJ 2. Melakukan perawatan jenazah dan menggunakan peralatan dan fasilitas secara mandiri 3. Melakukan komunikasi terapeutik dengan asertif pada pasien/keluarga, meliputi a. Penjelasan prosedur tindakan dan pengobatan b. Pendidikan kesehatan Dengan didampingi CI/Kaur/PJ 4. Mengajarkan latihan nafas dalam dan latihan batuk efektif 5. Melaporkan kondisi pasien/ pemeriksaan laboratorium per telephone ke dokter dengan didampingi PJ 6. Mengetahui dalam menyiapkan lumbal pungsi/pleura pungsi, dll 7. Memasang infus dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke VII	1. Melakukan perawatan pasien dengan tingkat ketergantungan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 2. Melakukan kolaborasi dengan bagian lain, laboratorium,	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang

	radiologi, apotik, admin, dll dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 3. Menyiapkan pasien untuk BNO-IVP, endoscopy, colonoscopy, pemeriksaan laboratorium 4. Menyiapkan/ melaksanakan prosedur pre/post op			Rawat Inap
Minggu ke VIII	1. Mengikuti dalam persiapan pasien tindakan endoscopy, colonoscopy, MRI-MRA, MSCT 2. Mengikuti visite dokter dan didampingi (delegasi dari CI/ kepala Ruang/ PJ) 3. Menyiapkan pasien dan peralatan tindakan lumbal pungsi/ pleura pungsi, dll dengan didampingi CI/ kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke IX	1. Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri meliputi pemberian injeksi melalui injeksi IV/ IM/ SC/ IC, obat oral/supp (anal/vaginal), inhalasi, NGT, Dower Catheter, perawatan luka 2. Merawat pasien dengan tingkat ketergantungan secara mandiri 3. Mengikuti visiting dokter secara mandiri 4. Melakukan konsul internal dan eksternal dokter spesialis RSPH 5. Memasang infus secara mandiri	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap

BAB X

PERTEMUAN / RAPAT

Rapat berkala terdiri dari:

1. Rapat Rutin Koordinasi

Rapat Rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Jumat (1 minggu sekali)

Jam : 13.00

Tempat : Hall RS Prima Husada

Peserta : Semua unit

Materi :

- 1) Pembacaan notulen rapat minggu lalu dan tindak lanjut
- 2) Pembacaan hasil Raker
- 3) Pembahasan laporan mingguan
- 4) Evaluasi kendala dan solusi

2. Rapat Kerja Bulanan RS

Rapat Rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Setiap 1 bulansekali

Jam : Menyesuaikan

Tempat : Ruang Rapat Hall

Peserta : Direksi, manajer, ketua komite, ka.Instalasi, ka.bagian

Materi :

- 1) Pembacaan notulen raker bulan lalu dan tindak lanjut
- 2) Presentasi laporan kinerja unit kerja
- 3) Evaluasi kendala dan solusi

3. Rapat Kerja Bulanan Unit

Rapat Rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Setiap 1 bulansekali

Jam : Menyesuaikan

Tempat : Ruang Rapat Hall

Peserta : kepala ruang/ kepala Unit, PJ Shift, Perawat Pelaksana

Materi :

- 1) Pembacaan notulen raker bulan lalu dan tindak lanjut
- 2) Presentasi laporan kinerja unit kerja
- 3) Pembahasan masalah yang ada di unit
- 4) Evaluasi kendala dan solusi

4. Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas segera.

BAB XI PELAPORAN

1. Laporan Harian
Laporan Supervisi Kepala Ruang
2. Laporan Bulanan
Laporan tertulis diserahkan ke Kepala Bidang Pelayanan dan dipresentasikan pada saat rapat kerja bulanan
3. Laporan Tahunan
Laporan dibuat sesuai format TOR unit kerja, bentuk laporan tertulis, soft copy dan diserahkan ke sekretaris direktur.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes